BONUS 2

Průvodce začátkem 6 stáží

Neuro, Hrudník, Břicho, Muskuloskeletální, Pediatrie a Intervenční/Prs: co musíte znát první den každé stáže, 10 nejčastějších vyšetření, typické chyby a kontrolní seznam pro první týden.

Obsah

Jak tuto příručku používat

Stáž 1 · Neuroradiologie

Stáž 2 · Hrudní radiologie

Stáž 3 · Břišní radiologie

Stáž 4 · Muskuloskeletální radiologie

Stáž 5 · Pediatrická radiologie

Stáž 6 · Intervenční radiologie a prs

Poslední den každé stáže

Další krok

ÚVODEM

Jak tuto příručku používat

Večer před nástupem na novou stáž si přečtěte příslušnou kapitolu: stačí 15–20 minut.

> *První týden stáže je týdnem, kdy se toho naučíte nejvíce, ale také se nejvíce ztratíte. Tento průvodce odpoví na otázku „kde mám začít?“ za vás.*

Každý oddíl věnovaný stáži se skládá ze stejných čtyř částí:

1. **Co musíte vědět první den** — fungování pracoviště, co se od koho naučit a základní témata, která byste si měli prostudovat jako první.
2. **10 nejčastějších vyšetření** — vyšetření, se kterými se na dané stáži setkáte nejčastěji, a první místo, na které se u každého z nich zaměřit.
3. **Typické chyby** — nejčastější úskalí rezidentů v 1. roce a jak se jim vyhnout.
4. **Kontrolní seznam na první týden** — konkrétní cíle, které byste měli být schopni na konci týdne odškrtnout.

Při každém vyšetření stejné 4 kroky

1 · PŘIPRAVTE

Identifikujte (pacient, vyšetření, datum, protokol) · Kvalita (technická přiměřenost) · Orientace (strana, rovina, okno/sekvence).

2 · PROJDĚTE

Každou oblast projděte pokaždé ve stejném pořadí. Nezastavujte se u prvního nálezu.

3 · POPIŠTE

Správnou terminologií (denzita / signál / echogenita), lokalizace, velikost, ohraničení. Porovnejte s předchozím vyšetřením a druhostranným nálezem.

4 · SHRŇTE

Závěr popisu, diferenciální diagnostika, doporučení. Urgentní nález ihned nahlaste.

Důležité

Na každém pracovišti se protokoly, šablony popisů a způsoby hlášení liší. Seznamy v této příručce představují obecný výchozí bod; pravidla vašeho pracoviště si vždy zjistěte od svého školitele a dodržujte je.

STÁŽ 1

Neuroradiologie

CT a MR mozku, páteř, hlava a krk. Zde se vytváří základ pro oblast, ke které budete ve službě voláni nejčastěji.

Co musíte vědět první den

- Oddělení **pořadí čtení CT mozku** naučte se a aplikujte totéž u každého vyšetření: krvácení, expanzivní chování a střední čára, komory a cisterny, diferenciace šedé a bílé hmoty, kostní okno, vedlejší dutiny nosní a mastoidy.
- **Okna** používejte správně: mozkové okno, iktové okno (úzké), kostní okno; v případě potřeby subdurální okno.
- **Akutní iktus** zjistěte si postup: jaká vyšetření (nativní CT, CT angiografie, perfuze, DWI) se na vašem pracovišti požadují, v jakém pořadí a kdo má být informován.
- Naučte se rozpoznávat sekvence MR: T1, T2, FLAIR, DWI/ADC, SWI nebo GRE, T1 po kontrastu. Vězte, co je na které sekvenci světlé a co tmavé.
- Naučte se z praxe oddělení roli CT u traumat páteře a situace, kdy je indikována MR.

10 nejčastějších vyšetření

#	VYŠETŘENÍ	PRVNÍ MÍSTO KE ZHODNOCENÍ
1	**Nekontrastní CT mozku (trauma)**	Extraaxiální krvácení, kontuze, fraktura lebky (kostní okno).
2	**Nekontrastní CT mozku (podezření na iktus)**	Přítomnost krvácení; časné známky ischémie, příznak hyperdenzní arterie.
3	**CT angiografie (hlava-krk)**	Okluze velkých cév, stenóza, disekce, aneuryzma.
4	**MR mozku (rutinní)**	Léze bílé hmoty na FLAIR, expanze, edém; restrikce na DWI.
5	**Rychlé iktové MR s DWI**	Vysoký signál na DWI, nízký signál na ADC: svědčí pro akutní infarkt.
6	**MR mozku s kontrastem**	Vzor sycení (prstencovité, nodulární, leptomeningeální, durální).
7	**CT krční páteře**	Linie zakřivení, zlomenina, postavení fazetových kloubů, prevertebrální měkké tkáně.
8	**MR bederní páteře**	Hernie disku, stenóza páteřního kanálu a foramin, útlak cauda equina.
9	**CT vedlejších nosních dutin**	Slizniční ztluštění, hladinka plynu a tekutiny, kostní destrukce, očnice.
10	**CT spánkové kosti / očnice**	Integrita kostí, zlomenina, denzita měkkých tkání, obsah očnice.

Typické chyby

- Při hodnocení pouze v mozkovém okně **vynechat kostní okno**; přehlédnout frakturu kalvy.
- Rozpoznat tenký subdurální hematom, hyperdenzitu podél lamina interna kalvy, pouze v širokém okně; **nepřepnout do subdurálního okna**.

- Popsat vysoký signál na DWI jako akutní infarkt bez kontroly ADC (efekt T2 shine-through).
- Popsat expanzivní chování a posun středočárových struktur jako »výrazný« bez číselného přeměření.
- Neporovnání s předchozím vyšetřením, ačkoliv je k dispozici.

Kontrolní seznam na první týden

- [ ] Postup čtení CT mozku znám nazpaměť a aplikuji jej u každého vyšetření stejně.
- [ ] Dokážu rychle přepínat mozkové, iktové, subdurální a kostní okno.
- [ ] Znám postup oddělení pro iktový program a urgentní hlášení nálezů.
- [ ] Z obrazu dokážu rozpoznat T1, T2, FLAIR, DWI/ADC a SWI.
- [ ] Porovnal jsem nejméně 20 nativních CT mozku s popisem svého školitele.
- [ ] Dokážu odlišit a popsat epidurální, subdurální a subarachnoidální krvácení.
- [ ] Jednou jsem si přečetl část o mozku ve Svazku 03 · CT a část o sekvencích ve Svazku 04 · MR.

STÁŽ 2

Hrudní radiologie

RTG plic, CT hrudníku a CT plicní angiografie. Zde je nejvíce popisovaných vyšetření.

Co musíte vědět první den

- **RTG plic** si stanovte pevné pořadí čtení: technika (rotace, inspirium, penetrace), kanyly a katétry, dýchací cesty, srdce a mediastinum, hily, plicní pole, pleura a úhly, podbrániční prostor, kosti a měkké tkáně.
- Znejte rozdíl mezi PA a AP snímkem: na AP projekci se srdeční stín může jevit větší; velikost srdce hodnoťte s ohledem na techniku snímkování.
- Na CT hrudníku **plicní a mediastinální okno** projděte samostatně od začátku do konce.
- Při CT plicní angiografii nejprve zhodnoťte adekvátnost časování kontrastní látky; pokud je nedostatečná, uveďte to v popisu.
- Na RTG snímcích z intenzivní péče je poloha tubusů, katétrů a drénů tím prvním, co je třeba zkontrolovat.

10 nejčastějších vyšetření

#	VYŠETŘENÍ	PRVNÍ MÍSTO KE ZHODNOCENÍ
1	**PA RTG snímek plic**	Technická adekvátnost, poté stálé pořadí čtení.
2	**Lůžkový AP RTG snímek (intenzivní péče)**	Endotracheální kanyla, centrální katétr, nazogastrická sonda, drén; pneumotorax.
3	**Bočný RTG snímek plic**	Retrosternální a retrokardiální prostor, zadní siny, obratle.
4	**Nekontrastní CT hrudníku**	Nodulus, konsolidace, matnicové zastření, emfyzém, pleurální výpotek.
5	**CT hrudníku s kontrastem**	Mediastinální a hilové lymfatické uzliny, expanze, cévní struktury.
6	**CT plicní angiografie**	Kvalita kontrastního naplnění; defekt v náplni plicních tepen; známky přetížení pravého srdce.
7	**CT s vysokým rozlišením (HRCT)**	Intersticiální obraz: retikulace, voštinovitá plíce (honeycombing), mléčné sklo, trakční bronchiektázie.
8	**Nízkodávkový screening / sledování uzlů**	Velikost nodulu, struktura a dynamika ve srovnání s předchozím vyšetřením.
9	**CT angiografie hrudníku (aorta)**	Intimální flap, pravé a nepravé lúmen, postižení odstupujících větví.
10	**UZ pleury (v případě potřeby)**	Přítomnost tekutiny, její množství a přítomnost sept.

Typické chyby

- Zastavit se po nalezení výrazného nálezu; **druhý nález** přehlédnout (např. kostní lézi, vzduch pod bránicí).

- Zapomenout, že na RTG snímku vleže se pneumotorax může hromadit spíše ventrálně a bazálně než v apexu.
- Opomenutí zkontrolovat „skryté oblasti“, jako jsou retrokardiální prostor, plicní hily a apexy.
- Nalézt nodulus a doporučit sledování bez porovnání s předchozím vyšetřením.
- Popsat CT angiografii plicnice s nedostatečným načasováním kontrastu jako »bez embolie«.

Kontrolní seznam na první týden

- [ ] Můj postup čtení RTG plic je stálý; u každého snímku dodržuji stejné pořadí.
- [ ] Zvládám popisovat polohy kanyl a katétrů způsobem požadovaným oddělením.
- [ ] Dokážu na RTG snímku rozlišit pneumotorax, pleurální výpotek, konsolidaci a atelektázu.
- [ ] CT hrudníku procházím odděleně v plicním a mediastinálním okně.
- [ ] Při CT plicní angiografii nejprve hodnotím kvalitu kontrastní náplně.
- [ ] Porovnal jsem nejméně 30 RTG snímků plic s popisem atestovaného radiologa.
- [ ] Prošel jsem část o hrudníku ve Svazku 02 · RTG a stránky o hrudníku v Atlasu nejčastějších nálezů.

STÁŽ 3

Břišní radiologie

CT, UZ, MR a nativní RTG břicha. Stáž, kde se nejvíce podílíte na rozhodování o akutních chirurgických výkonech.

Co musíte vědět první den

- Stálé pořadí hodnocení pro CT břicha: volný plyn a volná tekutina, parenchymatózní orgány (játra, slezina, pankreas, ledviny, nadledviny), žlučové cesty, střeva a mezenterium, cévy, lymfatické uzliny, pánev, kosti, plicní baze.
- **Kontrastní fáze** rozpoznejte (arteriální, portovenózní, odložená) a z protokolů pracoviště se naučte, která fáze je požadována pro jakou klinickou otázku.
- Zvykněte si přepínat do plicního nebo širokého okna pro pátrání po volném vzduchu.
- Naučte se standardní roviny UZ břicha pro pravý horní kvadrant, ledviny a pánev.
- U náhlé příhody břišní se seznamte s postupem hlášení urgentních nálezů (jako je volný plyn, aktivní krvácení, známky ischémie, strangulační ileus) na vašem pracovišti.

10 nejčastějších vyšetření

#	VYŠETŘENÍ	PRVNÍ MÍSTO KE ZHODNOCENÍ
1	**CT břicha a pánve s kontrastem (portovenózní fáze)**	Volný vzduch, volná tekutina, parenchymatózní orgány, střevní stěna.
2	**Nekontrastní CT (kamenový protokol)**	Litiáza v močovém traktu, hydronefróza, perirenální tuk.
3	**UZ břicha (pravý horní kvadrant)**	Žlučové kameny, tloušťka stěny, pericholecystická tekutina, šíře žlučových cest.
4	**UZ močového traktu**	Hydronefróza, velikost a parenchym ledvin, močový měchýř.
5	**Nativní RTG břicha vstoje**	Volný vzduch pod bránicí, hladinky tekutiny a plynu, šíře střevních kliček.
6	**CT nebo UZ při podezření na apendicitidu**	Průměr apendixu, stěna, okolní tuková tkáň, apendikolit, absces.
7	**Trauma CT**	Poranění parenchymatózních orgánů, aktivní extravazace kontrastní látky, volná tekutina.
8	**Dynamické CT/MR jater**	Chování léze při sycení v jednotlivých fázích.
9	**MRCP**	Defekt náplně ve žlučových cestách, stenóza, pankreatický vývod.
10	**UZ / MR pánve**	Struktury ovarií a dělohy, volná tekutina, expanze.

Typické chyby

- Hodnotit pouze v měkkotkáňovém okně a **volný plyn** přehlédnout.
- Soustředit se na hlavní nález a **plicní báze** a neprojít kosti.

- Najít konkrement v ledvině a ukončit hodnocení bez posouzení druhé strany a močového měchýře.
- Při vyšetření pro suspektní apendicitidu nepátrat po alternativních diagnózách (divertikulitida, ovariální patologie, ureterolitiáza).
- Popisovat lézi bez uvedení kontrastní fáze.

Kontrolní seznam na první týden

- [ ] Můj postup hodnocení CT břicha je stálý a u každého vyšetření stejný.
- [ ] Na snímku dokážu rozpoznat arteriální, portovenózní a odloženou fázi.
- [ ] Při každém vyšetření přepínám do širokého okna k vyloučení volného vzduchu.
- [ ] Zvládám pořídit standardní řezy UZ pravého horního kvadrantu.
- [ ] Znám postup urgentního hlášení u náhlé příhody břišní.
- [ ] Porovnal jsem nejméně 15 CT břicha s popisem svého školitele.
- [ ] Přečetl jsem si část o břichu ve Svazku 03 · CT a část o pravém horním kvadrantu ve Svazku 05 · UZ/POCUS.

STÁŽ 4

Muskuloskeletální radiologie

Traumatické snímky, MR kloubů a kostní léze. Kdo nehodnotí systematicky, přehlédne i tu nejjednodušší zlomeninu.

Co musíte vědět první den

- **U každého traumatologického RTG snímku minimálně dvě na sebe kolmé projekce** je nutné a nezapomínejte, že jedna projekce může zlomeninu skrýt.
- Postup hodnocení RTG skeletu: celistvost kortikalis, kloubní postavení, kloubní štěrbina, kostní tkáň (denzita a struktura), měkké tkáně (otok, tukové polštářky, vzduch).
- Naučte se postup popisu zlomeniny: kost a lokalizace, směr lomné linie, počet fragmentů, dislokace a angulace, postižení kloubu.
- Naučte se základní sekvence na MR kloubů (fat-sat PD/T2, T1) a které struktury se na které sekvenci zobrazují nejlépe.
- Systematický přístup ke kostní lézi: lokalizace, ohraničení (přechodová zóna), periostální reakce, matrix, měkkotkáňová složka.

10 nejčastějších vyšetření

#	VYŠETŘENÍ	PRVNÍ MÍSTO KE ZHODNOCENÍ
1	**RTG zápěstí**	Distální radius, skafoideum, uspořádání karpálních kostí.
2	**RTG hlezna**	Kotníky, vidlice hlezna, talus.
3	**RTG kyčlí a pánve**	Kortikalis krčku femuru, integrita pánevního kruhu.
4	**RTG ramene**	Vztah hlavice humeru ke glenoidu, fraktura, luxace.
5	**RTG kolene**	Tibiální plato, výpotek, kloubní štěrbina.
6	**MR kolene**	Menisky, zkřížené vazy, edém kostní dřeně, chrupavka.
7	**MR ramene**	Šlachy rotátorové manžety, labrum, šlacha bicepsu.
8	**Trauma CT (pánev, páteř, nitrokloubní zlomenina)**	Průběh lomné linie, počet fragmentů, kloubní plocha.
9	**RTG bederní / hrudní páteře**	Výška obratle, postavení, integrita pediklů.
10	**Hodnocení kostní léze (RTG, CT nebo MR)**	Přechodová zóna, periostální reakce, matrix, měkkotkáňová složka.

Typické chyby

- Nalezení jedné zlomeniny a **druhou zlomeninu** nebo nepátrat po přidružené luxaci.
- Jako je skafoid a krček femuru **u okultních zlomenin** nepomyslet na doporučení doplňujícího vyšetření nebo sledování, pokud je RTG snímek normální.

- Nehodnotit měkkotkáňové známky (příznak tukového polštářku, kloubní výpotek).
- Přehlédnout dorzální luxaci ramene na jediné RTG projekci.
- Ponechat popis kostní léze u jediného slova (»lytická«) bez systematického popisu.

Kontrolní seznam na první týden

- [ ] U každého traumatologického RTG snímku kontroluji dvě projekce.
- [ ] Při hodnocení RTG skeletu uplatňuji systematický postup (kortikalis, postavení, kloub, kost, měkké tkáně).
- [ ] Dokážu popsat zlomeninu v pořadí, které pracoviště vyžaduje.
- [ ] Na MR kolene dokážu zhodnotit menisky a zkřížené vazy sekvenci po sekvenci.
- [ ] Systematický přístup ke kostní lézi jsem uplatnil u případu od začátku do konce.
- [ ] Porovnal jsem nejméně 30 traumatologických RTG snímků s popisem atestovaného radiologa.
- [ ] Prošel jsem muskuloskeletální oddíl ve Svazku 02 · RTG a příslušný kontrolní seznam v Průvodci interpretací snímků.

STÁŽ 5

Pediatrická radiologie

Dítě není malý dospělý: odlišná anatomie, odlišná onemocnění a větší obezřetnost vůči radiaci.

Co musíte vědět první den

- **Princip radiační ochrany** má u dětí prioritu: pokud je to možné, preferuje se metoda bez záření (UZ, MR); je-li nutné CT, použije se pediatrický protokol pracoviště.
- Růstové štěrbiny, osifikační centra a věkem podmíněný normální vzhled se mohou zaměnit za frakturu; při pochybnostech **srovnání s druhou stranou** a využití atlasu se řídí zvyklostmi pracoviště.
- Mějte přehled o širokém využití UZ v pediatrii: např. invaginace, apendicitida, pylorus, kyčle a kraniální UZ.
- Pokud u dítěte uvidíte nevysvětlitelnou zlomeninu, zlomeniny v různém stadiu nebo nálezy neodpovídající anamnéze, na vašem pracovišti **postup hlášení na ochranu dítěte** sledujte společně se svým školitelem.
- Naučte se provozní postup na oddělení pro vyšetření vyžadující sedaci a přípravu.

10 nejčastějších vyšetření

#	VYŠETŘENÍ	PRVNÍ MÍSTO KE ZHODNOCENÍ
1	**RTG hrudníku u dětí**	Technika, stín brzlíku, konsolidace, air trapping, cizí těleso.
2	**UZ břicha (bolest břicha)**	Apendix, invaginace, volná tekutina, lymfatické uzliny.
3	**RTG lokte**	Tukové polštářky, osifikační centra, suprakondylická zlomenina.
4	**RTG předloktí a zápěstí**	Torus fraktury a zlomeniny vrbového proutku, růstová ploténka.
5	**UZ kyčelních kloubů (u kojenců)**	Vztah acetabula a hlavice femuru, metoda měření na oddělení.
6	**UZ močového traktu**	Hydronefróza, velikost ledvin, stěna močového měchýře.
7	**Kraniální UZ (novorozenec)**	Velikost komor, krvácení, echogenita parenchymu.
8	**UZ pyloru**	Tloušťka svaloviny pyloru a délka kanálu (podle kritérií pracoviště).
9	**Nativní snímek břicha**	Distribuce střevního plynu, obstrukce, cizí těleso.
10	**Nekontrastní CT mozku (trauma)**	Krvácení, zlomenina; shoda indikace s pravidly pracoviště.

Typické chyby

- Normální růstovou ploténku nebo osifikační jádro **považovat za zlomeninu**, nebo naopak.
- Přehlédnout možnost okultní zlomeniny při nálezu příznaku tukového polštářku na RTG lokte.
- Interpretovat normální stín thymu jako mediastinální expanzi.
- Reflexivní navržení CT u otázky, kterou lze zodpovědět pomocí UZ.
- Pouze popsat nález neodpovídající věku či anamnéze a nepomyslet na postup hlášení.

Kontrolní seznam na první týden

- [ ] Znám pediatrický CT protokol oddělení a pravidla radiační ochrany.
- [ ] Na RTG lokte dokážu zhodnotit pořadí osifikačních jader a tukové polštářky.
- [ ] Zvládám popsat torus fraktury, zlomeniny vrbového proutku a zlomeniny růstové ploténky.
- [ ] Alespoň několikrát jsem asistoval u UZ břicha zaměřeného na apendix a invaginaci.
- [ ] Postup hlášení na ochranu dítěte jsem se naučil od svého školitele.
- [ ] Viděl jsem příklady normálního thymu, normální růstové ploténky a normálních variant.
- [ ] Prošel jsem příslušné části ve Svazku 05 · UZ/POCUS a Svazku 02 · RTG.

STÁŽ 6

Intervenční radiologie a mamodiagnostika

Dva různé světy, jedno společné pravidlo: předzákroková příprava a popis snímku správným jazykem.

Co musíte vědět první den

INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

- Předzákroková kontrola: indikace, předchozí snímky, informovaný souhlas, laboratorní vyšetření a medikace požadované pracovištěm (rozhoduje váš školitel).
- Pravidla sterilního pole, radiační ochrana (olověná zástěra, krční límec, vzdálenost, čas) a použití dozimetru.
- Seznamte se s nejčastějšími výkony: biopsie pod UZ nebo CT kontrolou, drenáž abscesů a tekutinových kolekcí, perkutánní nefrostomie, centrální žilní přístup, angiografie.
- Pro pozákrokové sledování pacienta se seznamte s kontrolním seznamem pracoviště.

MAMÁRNÍ RADIOLOGIE

- Osvojte si standardní mamografické projekce (CC a MLO); porovnávejte oba prsy symetricky.
- V popisu **standardní klasifikační systém** a osvojte si terminologii používanou vaším pracovištěm; kategorii i doporučení uvádějte společně.
- Znejte základní znaky odlišující cystu od solidní léze na UZ prsu: tvar, ohraničení, vnitřní struktura, dorzální akustické fenomény.
- Srovnání s předchozími mamografiemi je v mamodiagnostice obzvláště důležité.

10 nejčastějších vyšetření a výkonů

#	VYŠETŘENÍ / VÝKON	PRVNÍ MÍSTO KE ZHODNOCENÍ
1	**Screeningová mamografie**	Symetrie, ložisko, kalcifikace, distorze architektury; porovnání s předchozím vyšetřením.
2	**Diagnostická mamografie**	Lokalizace klinického nálezu; potřeba doplňujícího zobrazení.
3	**UZ prsů**	Cystická, nebo solidní; tvar, ohraničení, orientace, dorzální akustické fenomény.
4	**Biopsie prsu pod UZ kontrolou**	Cílová léze, dráha jehly, adekvátnost vzorku.
5	**Biopsie štítné žlázy nebo lymfatické uzliny pod UZ kontrolou**	Cíl, okolní cévy, bezpečná dráha.
6	**Biopsie pod CT kontrolou**	Cíl a bezpečná dráha jehly; vztah k pleuře a cévám.
7	**Drenáž abscesu / tekutiny**	Velikost kolekce, obsah, bezpečná přístupová cesta.

#	VYŠETŘENÍ / VÝKON	PRVNÍ MÍSTO KE ZHODNOCENÍ
8	**Perkutánní nefrostomie**	Stupeň hydronefrózy, přístupová cesta k ledvině.
9	**Centrální žilní přístup / port**	Průchodnost cévy (UZ), poloha hrotu (skiaskopie nebo RTG snímek).
10	**Diagnostická angiografie**	Místo přístupu, anatomie cév, stenóza nebo zdroj krvácení.

Typické chyby

- Zahájení výkonu bez předchozího prostudování obrazové dokumentace.
- Zanedbání ochranných pomůcek proti záření a dozimetru.
- Hodnotit na mamografii pouze jeden prs a **porovnání symetrie** neprovést.
- Uvést kategorii v popisu prsu bez jasného doporučení.
- Neuvedení použité metody, počtu vzorků a přítomnosti komplikací v záznamu o výkonu.

Kontrolní seznam na první týden

- [ ] Znám předvýkonový kontrolní seznam oddělení a řídím se jím.
- [ ] Při každém výkonu používám své ochranné pomůcky proti záření a dozimetr.
- [ ] Asistoval jsem u nejméně 3 výkonů pod UZ kontrolou a zaznamenal si jejich jednotlivé kroky.
- [ ] Rozpoznám CC a MLO projekce a symetricky porovnávám obě prsa.
- [ ] Osvojil jsem si standardní kategorie a doporučení při popisu prsů.
- [ ] Dokážu popsat cystickou a solidní lézi na UZ prsu.
- [ ] Prošel jsem Svazek 05 · UZ/POCUS a příslušné případy ve Svazku 06 · Multimodální případy.

ZÁVĚR

Poslední den každé stáže

Při přechodu z jedné stáže na druhou 20minutové shrnutí upevní to, co jste se naučili.

1. **Vraťte se ke kontrolnímu seznamu.** Položky, které jste nemohli odškrtnout, si poznamenejte do prvního týdne další stáže.
2. **5 vyšetření, která vám dělají největší potíže** Zapište si do Cvičebnice: co jste přehlédli, proč jste to přehlédli, co uděláte příště.
3. **Požádejte svého školitele o krátkou zpětnou vazbu:** „Co bych měl na této stáži dělat lépe?“
4. **Část další stáže** přečtěte si jednou v této příručce.
5. **ve 12týdenním studijním plánu stáže** přizpůsobte následující týden své nové stáži.

> **Zlaté pravidlo**
>
> Na každé stáži si položte stejnou otázku: „Dokážu ve službě sám a bezpečně odečíst vyšetření z této oblasti?“ Pokud je odpověď „zatím ne“, doplňte to, co chybí, do kontrolního seznamu.

Vzdělávací účely. Tento materiál nenahrazuje předatestační přípravu, odborný dohled, klinický úsudek ani popis specialisty.

Další krok

Nyní si otevřete kapitolu své aktuální stáže a vytiskněte si kontrolní seznam na první týden.

Poté **Šablony pro prezentaci případu na vizitě**: přejděte k němu – najdete v něm, jak na vizitě prezentovat případy ze stáže během 60 nebo 120 sekund.